

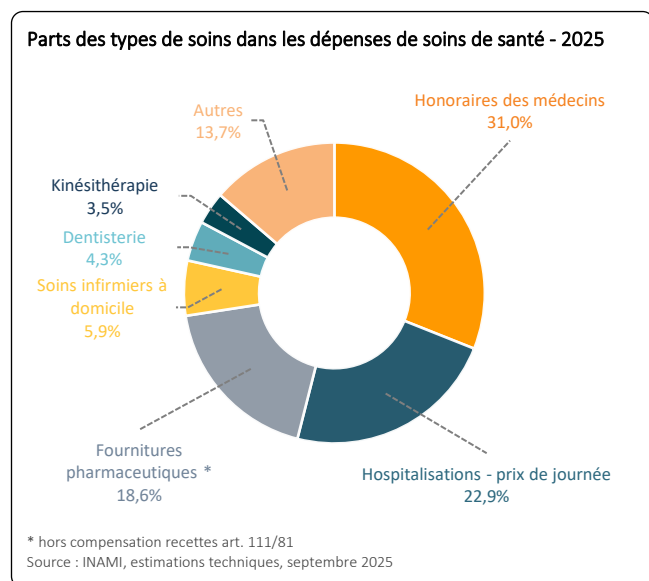
Projection sur la période 2025-2035 des dépenses de soins de santé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité

À politique inchangée, les dépenses réelles de soins de santé de l'assurance maladie-invalidité (exprimées en prix de 2025) devraient, dans le scénario de référence du modèle de projection PROMES, augmenter de 10,9 milliards d'euros au cours des dix prochaines années. Ceci représente une croissance annuelle réelle moyenne de 2,6%. Un tiers de cette croissance s'explique par l'évolution démographique, plus précisément le vieillissement (21%) et la croissance de la population (11%). Les fournitures pharmaceutiques devraient enregistrer la hausse la plus marquée (+3,4 milliards d'euros), résultant en partie du vieillissement de la population et de la nette augmentation des dépenses pour les médicaments innovants. On s'attend également à une forte progression des honoraires médicaux (+2,2 milliards d'euros), du prix de la journée d'hospitalisation (+2,1 milliards d'euros) et des soins infirmiers à domicile (+870 millions d'euros).

Auteurs : Joanna Geerts, jg@plan.be ; Karen Geurts, kg@plan.be

6% du PIB sont consacrés aux dépenses de soins de santé de l'assurance maladie-invalidité en 2025

En 2025, les dépenses de soins de santé couvertes par l'assurance maladie-invalidité (dépenses AMI) s'élevaient à 37,7 milliards d'euros, soit 6% du produit intérieur brut. Ce montant correspond à la part des dépenses publiques de soins de santé relevant de l'assurance obligatoire. Ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses de soins de santé des pouvoirs régionaux et locaux, ni d'une partie du financement distinct des hôpitaux par le [Budget des moyens financiers](#).

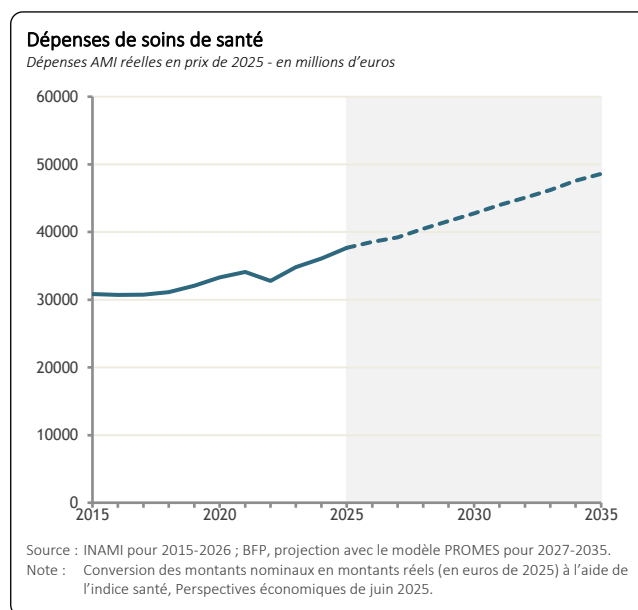


La majeure partie des dépenses est consacrée aux honoraires des médecins (31,0%), suivis du [prix de la journée d'hospitalisation](#) (22,9%) et des fournitures pharmaceu-

tiques (18,6%). Viennent ensuite les soins infirmiers à domicile (5,9%), la dentisterie (4,3%) et la kinésithérapie (3,5%).

Croissance réelle attendue de 2,6% par an en moyenne entre 2025 et 2035

Selon le modèle de projection PROMES (PROjecting MEDical Spending), les dépenses réelles liées à l'assurance maladie-invalidité devraient augmenter, à politique inchangée, de 10,9 milliards d'euros entre 2025 et 2035, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 2,6%. Cette croissance est identique à celle des cinq dernières années (2,6% entre 2020 et 2025), mais supérieure à celle de la période précédente (2,1% entre 2015 et 2020).





Augmentation des dépenses par type de soins

La croissance des dépenses estimée entre 2025 et 2035 varie considérablement selon le type de soins. En termes absolus, c'est au sein des trois principaux groupes de dépenses que les dépenses réelles augmentent le plus sensiblement : les fournitures pharmaceutiques (+3,4 milliards d'euros), les honoraires des médecins (+2,2 milliards d'euros) et le prix de la journée d'hospitalisation (+2,1 milliards d'euros). On s'attend également à de fortes hausses dans les soins infirmiers à domicile (+870 millions d'euros) et la kinésithérapie (+760 millions d'euros).

Les [maisons médicales](#), un groupe de dépenses plus restreint, devraient enregistrer, entre 2025 et 2035, la croissance la plus élevée en pourcentage. Les maisons médicales proposent des soins généraux, tels que les visites à domicile et les consultations chez le médecin généraliste, de la kinésithérapie et des soins infirmiers. Elles sont financées par l'assurance maladie au moyen d'un forfait mensuel par patient. Les patients ne paient pas de ticket

modérateur. Au cours des dix dernières années, le nombre de patients dans les maisons médicales a doublé et on prévoit, pour les dix prochaines années, une augmentation des dépenses réelles de près de 500 millions d'euros, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 8,6%.

La kinésithérapie arrive en deuxième position en termes de croissance importante en pourcentage. Entre 2025 et 2035, les dépenses réelles devraient augmenter en moyenne de 4,6% par an.

Les fournitures pharmaceutiques occupent la troisième place, avec une croissance réelle estimée à 4,1% par an en moyenne.

Pour les soins infirmiers à domicile, on prévoit aussi une croissance des dépenses supérieure à la moyenne (+3,3% par an). Cette augmentation s'explique en grande partie par le vieillissement de la population. Les projections tiennent compte du fait que la pénurie d'infirmiers à domicile freinera cette croissance.

Dépenses de soins de santé par type de soins

Dépenses AMI réelles en prix de 2025

Type de soins	En millions d'euros			Taux de croissance annuel moyen (en %)
	2025	2035	2025-2035	2025-2035
Honoraires des médecins - total	11 675	13 814	2 182	1,7
- Biologie clinique	1 540	1 669	130	0,8
- Imagerie médicale	1 770	1 863	93	0,5
- Consultations et visites à domicile	3 571	4 664	1 093	2,7
- Prestations spéciales, Chirurgie	3 500	3 975	475	1,3
- Autres : Gynécologie, Surveillance, Autres honoraires	1 252	1 643	391	2,8
Dentisterie	1 621	1 978	356	2,0
Fournitures pharmaceutiques*	6 988	10 401	3 412	4,1
Soins infirmiers à domicile	2 239	3 109	869	3,3
Kinésithérapie	1 335	2 093	758	4,6
Hospitalisations - prix de journée	8 629	10 686	2 057	2,2
Maisons médicales	389	886	498	8,6
Maximum à facturer	351	391	40	1,1
Soins à basse variabilité	463	546	83	1,7
Autres	4 019	4 696	677	2,3
Total*	37 666	48 599	10 933	2,6

* Il s'agit de résultats nets après déduction du montant de la « compensation des recettes article 81/111 » que les entreprises pharmaceutiques reversent à l'INAMI dans le cadre de conventions sur les médicaments.

Source : INAMI pour 2025-2026 ; BFP, projection avec le modèle PROMES pour 2027-2035.

Note : Conversion des montants nominaux en montants réels (en euros de 2025) à l'aide de l'indice santé, Perspectives économiques de juin 2025.

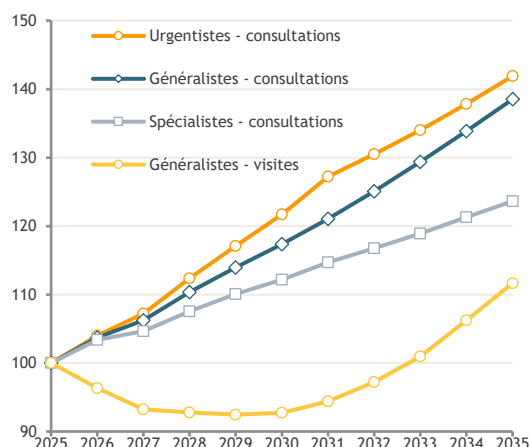
Enfin, en ce qui concerne les honoraires des médecins, on prévoit une forte augmentation pour les consultations et les visites à domicile, ainsi que pour la catégorie « autres », qui comprend notamment les honoraires des gynécologues et des médecins qui surveillent les patients hospitalisés.

Le graphique ci-dessous présente les dépenses estimées pour les consultations et les visites à domicile selon quatre

types de soins. La croissance des dépenses la plus marquée concerne les services d'urgence (consultations chez les urgentistes). Viennent ensuite les consultations chez les médecins généralistes. On s'attend à une croissance moins soutenue des consultations chez les spécialistes, et les dépenses liées aux visites à domicile des médecins généralistes augmentent peu.

Dépenses pour les consultations et visites à domicile, par type de soins

Dépenses AMI réelles (indice 2025 = 100)



Source : INAMI pour 2025-2026 ; BFP : projections avec le modèle PROMES pour 2027-2035.
Note : Conversion des montants nominaux en montants réels (en euros de 2025) à l'aide de l'indice santé, Perspectives économiques de juin 2025.

L'évolution attendue des prix est similaire pour les quatre types de soins, mais chez les médecins urgentistes, la hausse des dépenses est fortement liée à l'augmentation du nombre de patients, tandis que pour les consultations chez les médecins généralistes, c'est surtout l'augmentation du nombre de consultations par patient qui détermine cette croissance. S'agissant des visites à domicile, on s'attend à une baisse du nombre de patients au cours des prochaines années, malgré le vieillissement de la population. Si les personnes âgées recourent beaucoup plus souvent aux visites à domicile que les jeunes, on observe toutefois une tendance à la baisse pour ces visites, toutes tranches d'âge confondues, ce qui pourrait atténuer temporairement l'effet du vieillissement de la population.

Dans les autres types de soins, la croissance estimée des dépenses est inférieure à la moyenne. C'est particulièrement le cas pour la biologie clinique et l'imagerie médicale. La biologie clinique regroupe les analyses en laboratoire d'échantillons de sang ou d'autres liquides biologiques. Entre 2025 et 2035, la croissance annuelle des dépenses devrait atteindre +0,8% en moyenne. L'imagerie médicale comprend les examens réalisés par des radiologues à l'aide de radiographies, CT-scans, de la résonance magnétique nucléaire ou d'échographies. Dans ce domaine aussi, on prévoit une croissance modérée de +0,5% par an en moyenne.

Croissance supérieure à la moyenne des fournitures pharmaceutiques, liée à la hausse des dépenses consacrées aux médicaments innovants

Du côté des fournitures pharmaceutiques, la croissance devrait être supérieure à la moyenne, tant en termes relatifs qu'absolus. Les dépenses nettes augmenteraient de 3,4 milliards d'euros, soit de 49%, entre 2025 et 2035. Les dépenses nettes correspondent aux dépenses après déduction des compensations versées à l'INAMI par l'industrie pharmaceutique pour les médicaments visés à l'article 81/111. Il s'agit de médicaments innovants et prometteurs pour lesquels on ne dispose pas encore de données probantes sur leur efficacité, le coût par traitement et/ou leur impact budgétaire global. La plupart des conventions relatives à l'article 81/111 sont conclues pour le traitement de maladies rares, telles que les maladies métaboliques, et pour les traitements oncologiques. Ces médicaments sont payés par l'INAMI dans le cadre d'accords temporaires et sous certaines conditions. L'industrie pharmaceutique rembourse ensuite une partie du prix à titre de compensation budgétaire pour la mise sur le marché anticipée des médicaments. Pour la projection de ces compensations, nous utilisons le taux de croissance estimé de l'ensemble des médicaments relevant de l'article 81/111. Les dépenses brutes pour les fournitures pharmaceutiques, incluant les compensations, augmenteraient de 5,5 milliards d'euros, soit de 61%, entre 2025 et 2035.

Dépenses pour les fournitures pharmaceutiques

Dépenses AMI réelles en prix de 2025

	En millions d'euros		Croissance (en %)	
	2025	2035	2025-2035	2025-2035
Fournitures pharmaceutiques - brutes	8 961	14 455	+5 494	+61
Compensations article 81/111	1 973	4 054	+2 081	+106
Fournitures pharmaceutiques - nettes	6 988	10 401	+3 412	+49

Source : INAMI pour 2025-2026, BFP : projection avec le modèle PROMES pour 2027-2035.

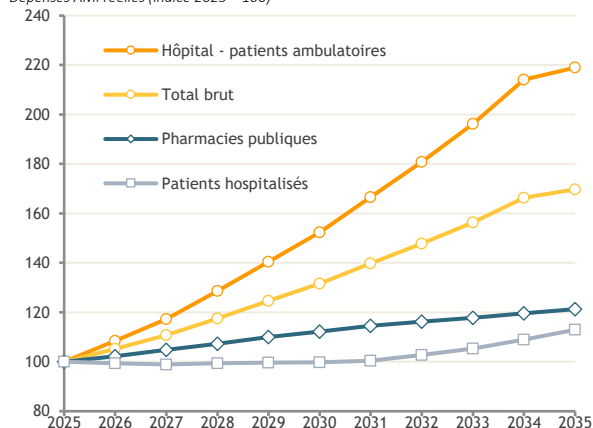
Note : Conversion des montants nominaux en montants réels (en euros de 2025) à l'aide de l'indice santé, Perspectives économiques de juin 2025.

L'examen par lieu de délivrance révèle que la hausse la plus marquée des dépenses brutes est attendue pour les médicaments administrés à des patients ambulatoires en milieu hospitalier. C'est également dans ce même contexte que s'effectue la plus grande part des délivrances de fournitures pharmaceutiques relevant d'une convention 'art. 81/111'.



Dépenses brutes pour les fournitures pharmaceutiques, par lieu de délivrance

Dépenses AMI réelles (indice 2025 = 100)



Source : INAMI pour 2025-2026, BFP : projection avec le modèle PROMES pour 2027-2035.

Note : Conversion des montants nominaux en montants réels (en euros de 2025) à l'aide de l'indice santé, Perspectives économiques de juin 2025.

Augmentation des dépenses sous l'effet de la croissance démographique et du vieillissement

Des facteurs importants expliquant l'augmentation des dépenses de soins de santé sont le vieillissement de la population et, dans une moindre mesure, la croissance démographique. Le tableau ci-dessous met en évidence la part de ces deux facteurs démographiques dans l'évolution des dépenses. Pour des raisons techniques, les chiffres de ce tableau débutent à partir de 2026.

Croissance des dépenses réelles et parts des facteurs démographiques

Dépenses AMI réelles en prix de 2026

2026-2035

Croissance des dépenses en millions d'euros

Total	10 198
dont :	
- hausse liée au vieillissement	2 147
- hausse liée à la croissance démographique	1 151
- hausse liée à l'ensemble des facteurs démographiques	3 298

Parts des facteurs démographiques dans la croissance des dépenses

- vieillissement	21%
- croissance démographique	11%
- facteurs démographiques dans leur ensemble	32%

Source : INAMI pour 2026, BFP : projections avec le modèle PROMES pour 2027-2035.

Note : Conversion des montants nominaux en montants réels (en euros de 2026) à l'aide de l'indice santé, Perspectives économiques de juin 2025.

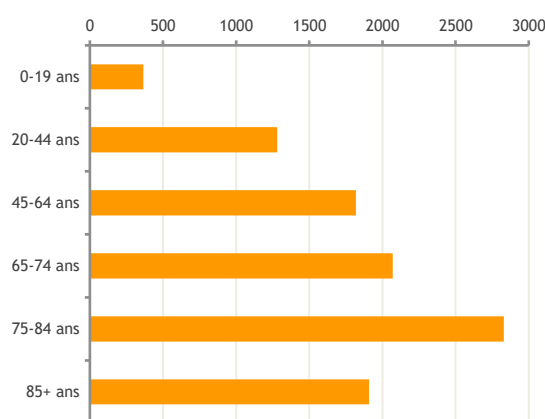
Entre 2026 et 2035, les dépenses AMI réelles devraient augmenter de 10,2 milliards d'euros, dont 21% sont liés au vieillissement de la population et 11% à la croissance

démographique. Un tiers (32%) donc de cette hausse des dépenses de soins de santé est imputable à des évolutions démographiques.

Le vieillissement de la population belge s'explique par plusieurs facteurs : l'allongement de l'espérance de vie, l'âge maintenant avancé de la génération du baby-boom et la baisse de la natalité. Étant donné que les dépenses AMI moyennes pour les personnes âgées sont sensiblement plus élevées que pour la population plus jeune, le vieillissement de la population entraîne une augmentation des dépenses AMI totales. Le vieillissement de la population se caractérise aussi par un allongement de l'espérance de vie des seniors. La part relative des personnes très âgées augmente plus rapidement que celle de tout autre groupe d'âge. Entre 2026 et 2035, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait s'accroître de 24%, tandis que celui des 65-75 ans augmente de 7% et que la population âgée de moins de 65 ans se contracte légèrement. Les dépenses moyennes pour les personnes très âgées sont nettement plus élevées que celles pour les personnes âgées plus jeunes, ce qui a pour effet de faire grimper encore davantage les dépenses totales de l'assurance maladie. À eux seuls, les plus de 65 ans représentent 66% de l'augmentation prévue des dépenses entre 2026 et 2035.

Croissance des dépenses réelles entre 2026 et 2035, par groupe d'âge

Dépenses AMI réelles en prix de 2026 - en millions d'euros



Source : INAMI pour 2026, BFP : projections avec le modèle PROMES pour 2027-2035.

Note : Conversion des montants nominaux en montants réels (en euros de 2026) à l'aide de l'indice santé, Perspectives économiques de juin 2025.



Le Bureau fédéral du Plan réalise chaque année des projections des dépenses publiques de soins de santé dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire (les dépenses AMI). Ces projections sont réalisées à l'aide du modèle PROMES (PROjecting MEDical Spending), un modèle de microsimulation des dépenses AMI, développé en collaboration avec l'INAMI. A partir de cette année, les résultats de PROMES seront publiés annuellement sur le site du BFP. Pour plus d'informations, voir [Geerts, J., Geurts, K. \(2024\), Description et utilisation du modèle PROMES. WP 1 DC2024. Bruxelles : Bureau fédéral du Plan.](#)

PROMES utilise principalement les données de l'Échantillon permanent ([EPS](#)). Les données utilisées pour cette publication proviennent de la version 19 de l'EPS. Les résultats des projections sont mis à jour chaque année et sont utilisés en soutien des estimations techniques de l'INAMI. Les résultats du modèle sont également utilisés pour élaborer les Perspectives économiques du BFP. Pour plus d'informations sur les projections du BFP des dépenses de soins de santé et leur lien avec les objectifs budgétaires du budget de l'INAMI, voir [Geerts, J., Geurts, K., Scholtus, B., Willemé, P. \(2025\). La projection des prestations de soins de santé dans les Perspectives économiques du Bureau fédéral du Plan. Bruxelles : Bureau fédéral du Plan.](#)